Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5024441-52.2024.8.21.0003/RS

REQUERENTE: MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHAES

REQUERIDO: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHAES ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, não especificado (CID10-C34.9)** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Durvalumabe 1500mg**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça (evento 33, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 39, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 43, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 46, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 48, DESPADEC1), nada requereram (evento 52, PET1; evento 53, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 56, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput*, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 33, DESPADEC1):

> *Segundo o laudo médico acostado aos autos, a parte autora apresenta o diagnóstico de **Neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, não especificado (CID C34.9),** necessitando fazer uso do medicamento **Durvalumabe 1500mg.** Ressaltou a **urgência** do tratamento, visto que a não utilização do fármaco coloca a vida da autora em risco (evento 1, ATESTMED3):*
>
> *[...]*
>
> *A nota técnica, por sua vez, sobreveio com **conclusão favorável** ao tratamento requerido (evento 30, NOTATEC1):*
>
> *[...]*
>
> *Ademais, foi juntada ao feito a negativa administrativa do IPE-SAÚDE (evento 1, COMP17).*
>
> *Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.*
>
> *Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.*
>
> *Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento,*

entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao IPE-SAÚDE que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Durvalumabe 1500mg**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, ATESTMED3), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, não especificado (CID10-C34.9)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Durvalumabe 1500mg**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento, salientando o laudo médico que o uso mais breve possível das medicações evitará a piora da qualidade de vida e o risco de óbito. Senão vejamos:

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

PACIENTE

MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES CPF: 227.071.230-72

Atestado Médico

LAUDO MÉDICO

Porto Alegre, outubro de 2024.
O presente laudo médico descreve a história oncológica da senhora MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, que foi recentemente diagnosticada com CÂNCER DE PULMÃO DE PEQUENAS CÉLULAS, e fundamenta a indicação e necessidade de tratamento com o protocolo formado pela combinação dos fármacos denominados DURVALUMABE, ETOPOSIDE E CARBOPLATINA.
Dou início ao presente relato destacando que a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, identificada com o CPF 227.071.230-72, encontra-se sob os meus cuidados desde setembro de 2024, devido ao diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO, subtipo CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS, também denominado CARCINOMA NEUROENDÓCRINO INDIFERENCIADO DE PEQUENAS CÉLULAS DE PULMÃO; o estadio clínico da doença é avançado, também chamado de "doença extensa ou extensiva", ou designado como 'IV' em algarismos romanos, devido à presença de metástases fora do tórax. A doença está registrada com o código alfanumérico CID C34.9 na Classificação Internacional de Doenças (CID). Anexado a este relatório está o laudo de ANATOMOPATOLÓGICO (biópsia), e os exames de imagem que revelam a extensão da doença. A Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES teve os sintomas da referida doença apenas recentemente. Frente à suspeita de neoplasia, a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES passou por punção pulmonar e teve o diagnóstico de neoplasia maligna confirmado entre setembro e outubro de 2024. Como é de rotina, após a confirmação da neoplasia maligna, a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES foi submetida a diversos exames para avaliar a extensão da doença. Após ter sido verificada a presença de metástases na região abdominal, foi proposto o manejo da condição com tratamento sistêmico por via endovenosa com quimioterapia (utilizando os fármacos chamados ETOPOSIDE E PLATINA) associada ao medicamento denominado DURVALUMABE, que pertence à classe de medicamentos denominados IMUNOTERÁPICOS. O tratamento com quimioterapia é fundamental para os pacientes com CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS DE PULMÃO; a IMUNOTERAPIA tem papel fundamental pois trata-se do maior avanço descoberto após décadas, para o melhor resultado e o melhor cuidado nos pacientes com esse tipo de tumor, exatamente como é o caso da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES. Ao longo de várias décadas, o tratamento dos pacientes com doença avançada, como é o caso da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, foi exclusivamente realizado com a combinação de dois medicamentos quimioterápicos. De fato, desde a década de 1960 e 1970 o tratamento se manteve igual até o ano de 2018, quando começaram a ser publicados os resultados de grandes estudos clínicos onde se comparava o tratamento convencional versus o mesmo tratamento acrescido de um medicamento IMUNOTERÁPICO. Os resultados foram surpreendentes, a ponto de mudar, de maneira consensual ao redor do mundo, o tratamento de pessoas com CANCER METASTÁTICO DE PULMÃO DE PEQUENAS CÉLULAS, exatamente como é o caso da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES. Todas as agências reguladoras ao redor do mundo, inclusive à correspondente no Brasil (ANVISA), indicam que esses pacientes devem ser tratados com quimioterapia associada à imunoterapia. Foram sucessivos estudos clínicos com sólidos resultados, que foram demonstrando o benefício dessa combinação para esses pacientes. A seguir menciono os trabalhos mais importantes nessa população de pacientes:

1. Estudo de fase III denominado "IMpower133", publicado nos prestigiosos jornais médicos "New England Journal of Medicine" e "Journal of Clinical Oncology". Nesse estudo, os pacientes que receberam a IMUNOTERAPIA combinada à Quimioterapia tiveram uma série de benefícios, sendo dignos de menção:
- O ganho significativamente superior em tempo de vida graças à IMUNOTERAPIA. - A redução do risco de morrer por câncer de aproximadamente 30% graças à IMUNOTERAPIA.
Referencia/link: * https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1809064?articleTools=true * https://ascopubs.org/doi/pdfdirect/10.1200/JCO.20.01055

2. Estudo de fase III denominado "CASPiAN", publicado no também prestigioso jornal médico "LANCET". Nesse estudo, a combinação da quimioterapia com o imunoterápico denominado DURVALUMABE trouxe um gigantesco benefício aos pacientes, quando comparado ao uso de

Este documento foi emitido e assinado digitalmente por CHRISTIAN SANDOR SVEND CHICATA SUTMOLLER:23018.RS através do sistema ESPACO MEDICO de

quimioterapia exclusiva. Cabe destacar: - Ganho significativo em tempo de vida em favor do DURVALUMABE. - Redução de aproximadamente 30% no risco de morrer por câncer de pulmão, graças ao DURVALUMABE. - De maneira impressionante, foi verificado que após três anos de acompanhamento, o número de pacientes vivos no grupo que havia recebido DURVALUMABE era o triplo em relação ao grupo que não havia recebido a imunoterapia. Significa que havia 3 vezes mais pessoas vivas no grupo do DURVALUMABE em comparação ao número de pacientes no grupo que havia recebido apenas imunoterapia. Referencia/link: * Lancet. 2019 Nov 23;394(10212):1929-1939. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32222-6. Epub 2019 Oct 4.

3. Estudo de fase III denominado KEYNOTE-604, publicado no "JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY". O estudo, assim como verificado nos anteriores, também demonstrou benefício em favor da imunoterapia, de maneira especial no controle do tempo livre de sintomas e de progressão do câncer. Referencia/link: * https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474472/pdf/JCO.20.00793.pdf * ascopubs. org/journal/ jco on May 29, 2020: DOI https://doi.org/10. 1200/JCO.20.00793 Vale destacar a grande diferença de pessoas vivas graças à adição de IMUNOTERAPIA à Quimioterapia em todos esses estudos: - Após 2 anos o dobro de pessoas vivas no grupo que recebe IMUNOTERAPIA versus o grupo que recebe apenas quimioterapia - No estudo CASPIAN, após três anos de realizado o tratamento, o número de pessoas vivas é o triplo no grupo que recebe IMUNOTERAPIA versus o grupo que recebe apenas quimioterapia.

Prosseguindo com a argumentação em favor do tratamento descrito, vale lembrar que em 04 de setembro de 2020, portanto, há 4 anos já, a ANVISA aprovou a indicação para usar DURVALUMABE combinado à Quimioterapia para pessoas com CANCER METASTÁTICO DE PULMÃO DE PEQUENAS CÉLULAS, exatamente como é o caso da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES. A indicação foi fundamentada em base aos resultados do estudo "CASPIAN" detalhado previamente, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 4 de setembro de 2020. A referida bula menciona o texto que transcrevo a seguir:
"...INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1. INDICAÇÕES - Câncer de pulmão de pequenas células (CPPC) IMFINZI (durvalumabe), em combinação com etoposídeo e carboplatina ou cisplatina, é indicado para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de pequenas células em estágio extensivo (CPPC-EE).
Fica muito claro e evidente, que o caso da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES se enquadra perfeitamente na indicação que consta na bula aprovada pela ANVISA. A Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES preenche todos os critérios para poder usufruir os benefícios desse tratamento; a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES não tem contraindicação para receber o tratamento com IMUNOTERAPIA combinada à Quimioterapia.
Destaco que a minha indicação está livre de qualquer conflito de interesse da minha parte ou dos meus familiares; a minha proposta terapêutica está embasada em critérios eminentemente científicos, respeitando todos os Princípios do Código de Ética Médica e tendo como premissas fundamentais o respeito à autonomia do paciente, a qual recebeu de forma didática e clara todas as explicações a respeito do tratamento proposto. A escolha e a decisão por realizar esse tratamento tem o consentimento livre e esclarecido da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES.
É importante mencionar que o Sistema Único de Saúde não disponibiliza opções de tratamento que sejam no mínimo equivalentes àquela por mim proposta; é necessário esclarecer, que a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES conta com plano que lhe garante assistência de saúde para realizar o seu tratamento oncológico. Trata-se de um direito fundamental e legalmente amparado, não apenas para a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, mas de todo cidadão.
Busca-se, com o tratamento proposto, atingir os resultados positivos constatados nos estudos clínicos de fase III, com a associação de IMUNOTERAPIA à Quimioterapia, a saber:
- Reduzir significativamente o risco de morrer por câncer.
- Aumentar significativamente o tempo de vida da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES.
- Melhorar a qualidade de vida da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES.
- Permitir que ela viva melhor e que possa conviver com seus familiares e continuar desempenhando o seu papel insubstituível na sociedade e no seu núcleo familiar, o que é fundamental para o bem-estar emocional do seu núcleo familiar.

A SEGUIR DESCREVO O NOME DA MEDICAÇÃO, A DOSE, FREQUENCIA DE USO E PRAZO DE TRATAMENTO:
- Durvalumabe, dose de 1.500 mg EV, aplicada em um dia a cada 3 semanas por 4 ciclos, seguidos de Durvalumabe, 1.500 mg EV, a cada 4 semanas por DOIS ANOS. Na etapa inicial, o DURVALumaBE será usado junto com a quimioterapia. Os medicamentos quimioterápicos são o ETOpoSIDE e a CarboPLAtINA, que será usados a cada 21 dias por quatro ciclos.

Elenco a seguir outras informações complementares, também relevantes para fundamentar o uso de imunoterapia (Durvalumabe) associado à quimioterapia para tratar a doença da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES:
- a imunoterapia, no caso o Durvalumabe é medicação insubstituível sem opções que fossem no mínimo equivalentes. Portanto, imprescindível para o tratamento do paciente e de pacientes com as mesmas condições que a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES
- a Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES não passou por tratamentos previamente; o diagnóstico foi confirmado recentemente e o tratamento de primeira linha é o que foi solicitado e o que deve ser realizado de imediato, com a combinação de quimioterapia e imunoterapia, conforme solicitado ao plano de saúde da paciente.
- Não existe opção melhor de tratamento na primeira linha para cuidar de pacientes com CARCINOMA PULMONAR DE PEQUENAS CÉLULAS, como é o o caso da Sra MARIA APARECIDA RAMOS

MAGALHÃES.
- Nas Diretrizes de Cobertura dos Tratamentos Oncológicos do Sistema IPE Saúde, publicados na Instrução Normativa IPE Saúde nº 02, de 27 de abril de 2021 (atualizada pela Instrução Normativo IPE Saúde nº 14, de novembro de 2021) consta apenas a quimioterapia, como forma de tratamento para pacientes com CARCINOMA PULMONAR DE PEQUENAS CÉLULAS; como já mencionado previamente neste relatório, a quimioterapia isolada é inferior ao tratamento combinado de quimioterapia com imunoterapia. Cabe destacar que a ANVISA aprovou o uso do Durvalumabe em casos exatamente iguais ao da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, com publicação no Diário Oficial da União (DOU) no dia 4 de setembro de 2020, com base no estudo fase III CASPIAN (mencionado previamente). Sendo assim, a aprovação e indicação no Brasil é oficial desde o ano de 2020, exatamente para casos como o da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, ou seja, para o tratamento de primeira linha de pacientes com CANCER DE PULMÃO DE PEQUENAS CÉLULAS. As Diretrizes do IPE Saúde são do ano seguinte à aprovação, inclusive com revisão posterior, mas ainda sem disponibilizar a medicação que aumenta o controle da doença, que aumenta a expectativa de vida, e que melhora a qualidade de vida dos pacientes; trata-se, portanto, de uma forma de tratamento desfavorável para os pacientes, caso se siga apenas a orientação limitada do IPE SAÚDE. No presente ano de 2024, quatro anos após a aprovação do DURVALUMABE para casos como o da Sra MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, o plano de assistência à saúde da paciente ainda não lista a melhor alternativa de tratamento, que, conforme já repetidamente descrito e argumentado neste laudo, corresponde a associar imunoterapia e quimioterapia; o IPE SAÚDE lista apenas protocolos de quimioterapia, com resultados inferiores em todos os desfechos esperados, o que leva os pacientes a terem menores expectativas de vida, pior qualidade de vida, os leva a morrerem de forma mais precoce e em curto perpiodo de tempo, apenas por não lhes ser permitido associar a imunoterapia ao tratamento com quimioterapia.
Finalizo o atual relatório, ressaltando que há risco, frente à demora, de antecipar a morte do paciente, ainda mais pelo fato do convenio já ter negado à medicação à paciente. Resta evidente, frente a esse potencial risco, a urgência do caso. Pelo exposto, solicito seja dada a diligência ao caso, assim como a pronta liberação do seu tratamento,
Atenciosamente,

_____
Christian C. Sutmöller
Oncologista CREMERS 23018

24 de Outubro de 2024

CHRISTIAN SANDOR SVEND CHICATA SUTMOLLER CRM-RS: 23018

Oncologia Clínica (RQE: 15917), Clínica Médica (RQE: 15916)

Endereço Comercial: RUA COSTA 40, 7O ANDAR, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE - RS

ICP Brasil

Atestado emitido no dia 24/10/2024 21:53:28 por CHRISTIAN SANDOR SVEND CHICATA SUTMOLLER - 23018/RS para MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES (CPF: 227.071.230-72 tramosmagalhaes@gmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador/atestado/5H3ACN5J** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Ainda, o laudo médico atualizado indica que a paciente apresentou excelente resposta clínica ao uso da medicação pleiteada e não há toxicidade grave ao tratamento (evento 53, ATESTMED2):

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

PACIENTE

MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES CPF: 227.071.230-72

Atestado Médico

LAUDO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que a senhora MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, é portadora de CÂNCER DE PULMÃO DE PEQUENAS CÉLULAS.
A paciente está em tratamento com imunoterapia com o fármaco Durvalumabe; esclareço que no presente momento a paciente apresenta excelente resposta ao Tetê to, com remissão importante da neoplasia, com melhora clínica excelente e sem toxicidade grave ao tratamento.

Atenciosamente,

Christian C. Sutmöller
Oncologista CREMERS 23018

01 de Abril de 2025

CHRISTIAN SANDOR SVEND CHICATA SUTMOLLER CRM-RS: 23018

Oncologia Clínica (RQE: 15917), Clínica Médica (RQE: 15916)

Endereço Comercial: RUA COSTA 40, 7O ANDAR, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE - RS

ICP Brasil

Atestado emitido no dia 01/04/2025 17:16:01 por CHRISTIAN SANDOR SVEND CHICATA SUTMOLLER - 23018/RS para MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES (CPF: 227.071.230-72 tramosmagalhaes@gmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador/atestado/4JPNHjbG** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Este documento foi emitido e assinado digitalmente por CHRISTIAN SANDOR SVEND CHICATA SUTMOLLER:23018/RS através do sistema ESPACO MEDICO do

Com efeito, o médico assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo médico assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram*

os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por MARIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Durvalumabe,** na dosagem e periodicidade determinadas pelo médico assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 08/05/2025, às 14:16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082086852v5** e o código CRC **8904e457**.